Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Estadual da Saúde Pública

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacentvesp@tjrs.jus.br

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE Nº 5006795-98.2025.8.21.0001/RS

REQUERENTE: VANESSA LOPES BACKES
REQUERIDO: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

Vistos.

VANESSA LOPES BACKES ajuizou ação ordinária em face do **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, alegando possuir diagnóstico de **Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos (CID10-F33.2)**. Refere que, em razão de sua enfermidade, necessita fazer uso do medicamento **Cloridrato de Escetamina**, cujo uso deverá ser de forma contínua. Requereu, em sede antecipatória do mérito, o fornecimento do medicamento pelo réu e, ao final, a procedência do pedido (evento 1, INIC1).

Deferida a gratuidade da justiça (evento 19, DESPADEC1).

Indeferida a tutela de urgência (evento 35, DESPADEC1).

Citado, o réu apresentou contestação, alegando, em síntese, o não preenchimento dos requisitos fixados pelo STJ no julgamento do Tema 106 para o reconhecimento judicial do dever do Poder Público em fornecer medicamentos não instituídos pela gestão pública. Requereu a improcedência da demanda (evento 44, CONT1).

Não houve réplica (evento 50).

Oportunizada a dilação probatória (evento 51, ATOORD1), a parte autora não se manifestou (evento 55) e o demandado nada requereu (evento 58).

O Ministério Público opinou pela improcedência da ação (evento 62, PROMOÇÃO1).

É o relatório.

Decido.

DA COMPETÊNCIA

A questão da competência está superada pela tese fixada no RE 1.366.243/SC, Repercussão Geral - Tema 1234, publicado em 19/09/2024. Segue o trecho do voto relativo à competência, com redação alterada após o julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina:

> *I - Competência 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.*

No ponto, houve a modulação de efeitos para aplicação aos processos ajuizados após a publicação do julgamento no DJE, que ocorreu em 19/09/2024:

> *Por fim, modulo os efeitos da presente decisão, unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial nesta Corte), propondo que somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico.*

Ainda sobre a competência, o Ministro Relator, no voto vencedor, que acolheu em parte os Embargos de Declaração opostos pela União, definiu:

> *3) acolho parcialmente os embargos opostos pela União, tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do voto condutor do acórdão embargado a remissão ao "item 1 do acordo firmado na Comissão Especial", por referir-se unicamente aos medicamentos não incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem*

ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico.

No caso, o ajuizamento do processo ocorreu em 12/01/2025, o fármaco postulado não é incorporados ao SUS e o valor anual do medicamento não ultrapassa 210 salários-mínimos com base no PMVG.

Assim, a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual.

Verifica-se a regularidade do feito, a legitimidade das partes e sua devida representação, sem nulidades ou irregularidades a serem sanadas.

DO MÉRITO

Direito à Saúde

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, *caput*, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, garantiu o direito à vida e em seu artigo 6º, *caput,* que cuida dos direitos sociais, assegurou o direito à saúde, dentre outros. Não bastasse isso, o artigo 196, que trata da ordem social, prescreveu o direito à saúde e o dever do Estado. A Lei 8.080/90, em seu artigo 2º, reiterou que a saúde é um direito fundamental do cidadão, incumbindo ao Estado prover as condições ao seu pleno exercício, disciplinando o SUS – Sistema Único de Saúde -, e incumbindo aos entes públicos a prestação de serviços de saúde à população.

A Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, no mesmo sentido, em seu artigo 241, preceitua que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado e do Município, a ser ofertada através de sua promoção, proteção e recuperação.

O acesso à saúde é direito fundamental e as políticas públicas que o concretizam devem gerar proteção suficiente ao direito garantido, sendo passíveis de revisão judicial, sem que isso implique ofensa aos princípios da divisão de poderes, da reserva do possível ou da isonomia e impessoalidade. Nesse sentido a Apelação Cível nº 70050003987, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 31/07/2012.

Do tratamento postulado

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal tratou dos requisitos para o fornecimento de medicamentos na via judicial, por meio dos Temas n°s 1234 e 6, que geraram as respectivas Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61, abaixo reproduzidas:

Súmula Vinculante 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

Súmula Vinculante 61: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

Através da edição o Tema nº 06, o STF fixou a tese de que é possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

Ainda, conforme a tese firmada no Tema 1234 do STF, estabeleceu-se que:

IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de ***medicamento*** *pelo SUS. 4)* ***Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.*** *4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a*

simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. (Grifou-se)

É importante ressaltar que com início em janeiro de 2025, o processo foi devidamente saneado de acordo com o julgamento dos relevantes Temas referentes ao fornecimento de medicamentos, bem como os documentos foram requeridos alinhados a essas deliberações.

Do não atendimento aos requisitos constantes nos Temas 1234 e 6 do STF

No presente feito, embora o medicamento **Cloridrato de Escetamina** possua registro na ANVISA, não foi avaliado pela CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde) para qualquer patologia; portanto, o medicamento é considerado não incorporado ao SUS.

No caso em análise, a autora juntou aos autos a comprovação da negativa administrativa advinda pela Farmácia de Medicamentos do Estado (FME), conforme documento juntado no evento 1, OUT5, bem como comprovou a sua condição de hipossuficiente, atendendo, respectivamente, os itens (a) e (f) do Tema 6 do STF.

Contudo, os demais requisitos não foram devidamente comprovados pela parte autora.

Quanto ao item (c), que trata da impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, a nota técnica elaborada pelo e-NatJus no evento 33, NOTATEC1 destacou a existência de outras opções de tratamento disponibilizados gratuitamente pelo SUS e salientou que não há relato de uso prévio dessas alternativas medicamentosas (como os antidepressivos tricíclicos):

O SUS disponibiliza as seguintes medicações para melhora de quadros comportamentais associados a transtornos psiquiátricos que podem ser prescritas de acordo com possíveis necessidades e sintomatologias específicas se associadas ao quadro de base: haloperidol, carbonato de lítio, clorpromazina, carbamazepina, ácido valpróico, propranolol, fluoxetina, amitriptilina, nortriptilina, clomipramina, prometazina, biperideno, diazepam e clonazepam. As medicações citadas podem ser utilizadas em monoterapia ou em combinações medicamentosas.

Para os quadros ansiosos e depressivos os antidepressivos com propriedades ansiolíticas: fluoxetina, nortriptilina, amitriptilina e clomipramina. O lítio e outros anticonvulsivantes também podem ser usados como adjuvantes. Além destas opções, também são disponibilizados pelo SUS para quadros de ansiedade os medicamentos da classe dos benzodiazepinicos: diazepam e clonazepam. Apesar dos benzodiazepínicos serem considerados medicamentos eficazes para ansiedade, atualmente são preteridos em relação às medicações citadas anteriormente devido aos seus efeitos colaterais, especialmente o risco de desenvolvimento de dependência

Não há, por meio dos laudos médicos juntados pela autora, justificativa plausível para fundamentar o medicamento específico pleiteado nestes autos. Embora atestem que a parte autora já fez uso de outros medicamentos, não há comprovação suficiente da ineficácia de todos os tratamentos disponíveis no SUS.

No que se refere ao item (d), que exige a comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, a parte autora não trouxe aos autos ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise que comprovem a eficácia do medicamento pleiteado para o seu caso específico.

Assim, não demonstrada a comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise, consoante preconizado pelos Temas referidos.

Para comprovar a necessidade do medicamento, o laudo médico não deve se basear apenas em observações clínicas. É fundamental que ele apresente **estudos científicos robustos**, como **ensaios clínicos randomizados**, **revisões sistemáticas** ou **meta-análises**. Tal não ocorreu no caso em tela.

Por fim, quanto ao item (e), que trata da imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, a nota técnica elaborada pelo e-NatJus no evento 33, NOTATEC1 foi conclusiva ao afirmar que:

Recomendações da CONITEC para a situação clínica do demandante: Não avaliada

Conclusão

Tecnologia: CLORIDRATO DE ESCETAMINA

Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão: CONSIDERANDO o diagnóstico de Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos constante no relatório médico acostado ao processo;

CONSIDERANDO a NT 322797 e o novo relatório médico acostado aos autos;

CONSIDERANDO que a medicação pleiteada é a Escetamina para requerente de 37 anos de idade;

CONSIDERANDO que, apesar da medicação pleiteada poder ter efeitos benéficos para o quadro do requerente, há disponíveis no SUS medicações com eficácia não inferior (como os antidepressivos tricíclicos) que não foram citadas como já utilizadas pela requerente segundo os relatórios acostados ao processo;

CONSIDERANDO que para que o uso das medicações no quadro clínico apresentado pela requerente resulte em melhora dos sintomas é necessário a utilização por um período de tempo e dosagem adequados, sendo necessário em alguns casos a combinação de medicamentos entre si;

CONSIDERANDO que os efeitos colaterais e a eficácia da resposta das medicações utilizadas nos quadros mentais citados acima são dependentes do tempo de uso e da dosagem utilizada;

CONSIDERANDO que nos relatórios médicos apensos ao processo, apesar da referência ao uso de prévio de outras medicações (vide fls. 11, 154, 155, 171, 172) e a menção a algumas das doses utilizadas, não há referência ao período de tratamento específico em que tais medicações foram utilizadas e nem por quanto tempo cada dose foi usada para o quadro clínico da requerente;

CONSIDERANDO que o SUS disponibiliza, além do tratamento medicamentoso, o acompanhamento psicossocial para o quadro da requerente, geralmente realizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS);

CONSIDERANDO que nos relatórios médicos acostados ao processo não há relatórios médicos de acompanhamento emitidos por Unidade Básica de Saúde (UBS) e/ou Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do SUS;

CONSIDERANDO que nos relatórios acostados ao processo não foram evidenciados quais tratamentos não medicamentosos, incluindo psicoterapia, seja individual ou em grupo, outras modalidades de tratamento multiprofissional previsto no SUS, já foram realizados ou não durante o tratamento da requerente;

CONSIDERANDO que com os dados fornecidos nos relatórios médicos acostados ao processo não é possível se demonstrar de forma definitiva refratariedade ao tratamento psicossocial e aos fármacos disponíveis para o SUS para o quadro clínico apresentado pela requerente em monoterapia ou em combinações medicamentosas com otimização progressiva das dosagens das mesmas até, se não houver contraindicações, a dosagem máxima permitida pela literatura

científica;

CONSIDERANDO que a avaliação de incorporação de medicamentos/procedimentos pelo SUS conduzida pela CONITEC é um processo complexo que analisa entre múltiplos aspectos, pontos relevantes como a relação custo-benefício, custo-efetividade, impacto orçamentário e evidências clínicas do medicamento/procedimento sendo fundamentada em princípios de transparência, participação social e evidências científicas, visando sempre a promoção da saúde pública com responsabilidade e eficiência econômica;

CONSIDERANDO que caso houvesse sido evidenciado refratariedade às medicações e tratamento psicossocial disponíveis pelo SUS, e apesar da medicação pleiteada poder ter efeitos benéficos para o quadro da requerente, além das medicações com dispensação prevista pelo SUS há medicações disponíveis no mercado farmacológico brasileiro com eficácia evidenciada em estudos científicos, que não foram citadas como já utilizadas pelo requerente em monoterapia ou em combinações medicamentosas, que potencialmente podem apresentar custo financeiro mensal significativamente menor do que a medicação pleiteada, com consequente melhor relação custo-efetividade, não tendo sido evidenciado razões tecnicamente embasadas em para a escolha da medicação em pleito, em detrimento das mesmas;

CONSIDERANDO que o médico assistente, se considerar indicado, pode solicitar internação psiquiátrica voluntária ou involuntária em casos de risco iminente de suicídio;

CONSIDERANDO que com os dados fornecidos nos relatórios médicos acostados ao processo não é possível se demonstrar de forma definitiva refratariedade aos fármacos disponíveis para o SUS para o quadro clínico apresentado pela requerente;

CONSIDERANDO que os diagnósticos supracitados representam condições clínicas crônicas não tendo sido evidenciado nos autos razão para considerar risco iminente de vida ou perda irreversível de órgão ou função;

CONCLUI-SE que não há elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação do medicamento pleiteado.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não

Importante destacar que o STF deu ênfase que ficará sujeita a nulidade a decisão judicial que condenar o ente público à dispensação de fármaco sem a estrita observância dos requisitos estipulados nas teses mencionadas, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil.

Dessa forma, não estando comprovados pela demandante os requisitos fixados pelos Temas 1234 e 6 do STF (itens "c", "d" e "e"), a ação deverá ter um juízo de improcedência.

Nesse sentido, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

> *DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL.* ***FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. CLORIDRATO DE ESCETAMINA (SPRAVATO).*** *AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. LAUDO MÉDICO PADRONIZADO. R****EQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ NÃO PREENCHIDOS.*** *DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME:1. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO CLORIDRATO DE ESCETAMINA (SPRAVATO) 28MG PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE, EPISÓDIO ATUAL GRAVE COM SINTOMAS PSICÓTICOS E LESÃO AUTOPROVOCADA INTENCIONALMENTE POR MEIOS NÃO ESPECIFICADOS (CID 10 F33.3 E X84.0). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE NA POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS, CONSIDERANDO O LAUDO MÉDICO APRESENTADO E OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO STJ NO TEMA 106. III. RAZÕES DE DECIDIR:1. A DEMANDA ENVOLVE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO ÀS LISTAS DO SUS, APLICANDO-SE O ITEM 5.2 DA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO RE Nº 1.366.243-SC (TEMA 1234), QUE DETERMINA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO PELO JUÍZO AO QUAL A AÇÃO FOI DIRECIONADA PELO CIDADÃO, SEM NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO.2. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO RESP 1.657.156/RJ (TEMA 106), ESTABELECEU TRÊS REQUISITOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS: COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO E INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS DISPONÍVEIS NO SUS, INCAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE E REGISTRO DO MEDICAMENTO NA ANVISA.3. O LAUDO MÉDICO APRESENTADO NÃO COMPROVA A IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO, POIS APRESENTA HISTÓRICO MEDICAMENTOSO IDÊNTICO AO DE OUTROS PACIENTES EM DEMANDAS ANÁLOGAS, COM OS MESMOS PERÍODOS DE USO E RAZÕES DE INEFICÁCIA PARA TODOS OS MEDICAMENTOS LISTADOS.4. VERIFICOU-SE QUE TODOS OS LAUDOS SÃO DE LAVRA DO MESMO MÉDICO, O QUE COMPROMETE A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, CONFORME PRECEDENTES DA CORTE EM CASOS IDÊNTICOS.5. A PARTE AUTORA, INTIMADA PARA APRESENTAR COMPROVANTES DO TRATAMENTO JUNTO AO CAPS E RECEITUÁRIOS MÉDICOS DOS MEDICAMENTOS LISTADOS NO LAUDO, NÃO TROUXE QUALQUER DOCUMENTO, O QUE REFORÇA A FRAGILIDADE DA PROVA APRESENTADA.6. PREVALECE O LAUDO ELABORADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO JUDICIÁRIO, PRODUZIDO POR PROFISSIONAL CAPACITADO E ISENTO, QUE NÃO RECONHECEU A IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO PLEITEADO. IV. DISPOSITIVO E TESE:1. RECURSO DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 2%, CUJA EXIGIBILIDADE RESTA SUSPENSA EM FACE DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.TESE DE JULGAMENTO: 1. O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS EXIGE A COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO E DA INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS DISPONIBILIZADOS PELO SISTEMA PÚBLICO, NÃO SENDO SUFICIENTE LAUDO MÉDICO PADRONIZADO QUE APRESENTE HISTÓRICO MEDICAMENTOSO IDÊNTICO AO DE OUTROS PACIENTES. _____DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, ARTS. 85, §11, 300, 487, I; CF/1988, ART. 196.JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, RE 1.366.243-SC (TEMA 1234); STJ, RESP 1.657.156/RJ (TEMA 106); TJRS, AGINST Nº 50344316220238217000, 3ª CÂMARA CÍVEL, REL. DES. LEONEL PIRES OHLWEILER, J. EM 22JUN23; TJRS, AC Nº 50007861720228210134, 4ª CÂMARA CÍVEL, REL. DES. EDUARDO UHLEIN, J. EM 22AGO2024; TJRS, AC-RN Nº 50506983320188210001, 4ª CÂMARA CÍVEL, REL. DES. EDUARDO UHLEIN, J. EM 24OUT23.(Apelação Cível, Nº 50016384020238210026, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antonio Monteiro Pacheco, Julgado em: 28-08-2025)[grifou-se]*

Assim, não merece acolhimento a pretensão da parte autora.

Ante o exposto, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC, **JULGO IMPROCEDENTE** o pedido ajuizado por VANESSA LOPES BACKES contra o **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**.

Pela sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios ao procurador da parte adversa, que arbitro em R$ 2.000,00, na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade da justiça deferida no evento 19, DESPADEC1 (art. 98, § 3º do CPC).

Caso interposto recurso de apelação, cumpram-se as formalidades dos §§ 1º e 2º, do art. 1.010, do CPC e, após, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Agendada a intimação eletrônica das partes.

Com o trânsito em julgado, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **LETICIA MICHELON, Juíza de Direito**, em 05/11/2025, às 19:13:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10094704329v7** e o código CRC **a9753103**.